



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : كريمه عبدالرازق عبدالنعم مهران

العنوان : -

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 28009010111482 رقم التليفون : 01100509425

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-09-1980 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كريمة عبدالرازق عبدالنعم مهران National ID: 28009010111482	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
مطالبة تحقيق الشخصية



كريمة
عبدالرازق عبدالنعم مهران
١٢ ش ٥
المصرية - القاهرة



٢٨٠٠٩٠١٠١١٤٨٢

KC2957964



٢٠٢٣/٠٨ ٢٨٠٠٩٠١٠١١٤٨٢
ربة منزل

متزوجة
مسلمة
أشرف خنيس احمد محمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/٠١



Patient Name	: كريمه عبد الرازق عبد النعيم	Request No.	: 13000727
Patient No.	: 28009010111482	Request Date	: 28/07/2022
Path No.	: 2125/22	Verification Date	: 17/08/2022
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT**Clinical Data:**

Left breast mass.

Nature of the specimen: Tru cut biopsy collected at 28/7/2022 at 3.00 pm.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores, up to 1.5 cm long, totally submitted.

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
 - Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GIII(3+3+2).
 - Angioinvasion: No in the received biopsy.
 - Ductal carcinoma in situ: No in the received biopsy .
 - IPT:
- ER: No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8)
 PR: No nuclear reaction intumor cells (Allred score 0/8)
 Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
 Ki 67: 25 % nuclear reaction in tumor cells
 Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:

Left breast mass; Tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma GIII.
- No Angioinvasion in the received biopsy.

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 17/08/2022 11:16:45

Page 1 of 2

Printed By : dr.esraa magdy

Name: كريمه عبد الرزاق عبد النعيم مهران		
MR. : 5421		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 45-year-old individual with HER2-positive breast cancer (TCHP) who underwent left breast-conserving surgery in March 2023. Post-operative management included adjuvant HERCEPTIN administered subcutaneously via a port, which was subsequently placed on follow-up pause. Recent imaging with a chest CT scan was reported as normal. The current plan is continued surveillance.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	اسماء محمد مصطفى نصر
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name كريمه عبد الرازق عبد النعيم
Patient No. 28009010111482
Path No. 2125/22
Sex Male
Age 42 Y
Referreing Doc.

Request No. 13000727
Request Date 28/07/2022
Verification Date 17/08/2022
Financial Category اوزام دار السلام - مبانره
Department Out Patient
Registered by .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- No Ductal carcinoma in situ in the received biopsy.
 - IPT :
- ER: Negative (score 0/8).
PR: Negative (score 0/8).
HER-2: Positive (score 3+).
Ki67: Positive in 25% of tumor cells.

Prof. Dr. Amal Hareedy.

Dr. Menna Nabil.

Dr. Abdelrahman Ibrahim

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 17/08/2022 11:16:45

Page 2 of 2

Printed By : dr.esraa magdy

Patient Name	: كريمه عبد الرازق عبد النعيم	Request No.	: 13009647
Patient No.	: 28009010111482	Request Date	: 14/03/2023
Path No.	: 793/2023	Verification Date	: 06/04/2023
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

(Amended Report)

Clinical Data: Left breast cancer, (post neoadjuvant therapy)

Nature of the specimen: Left BCS & ALND

Gross Examination:

Two specimens were received submitted as:

1-Left BCS measuring 10x9.5x6 cm, with skin covering; 8x6cm. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white clipped tumor bed site measuring 1.5x1x1 cm, located 2 cm, 3cm, 1.5cm, 3 cm, 4cm, away from deep, superficial, inferior, lateral, medial, resection margin respectively. another grey white area 0.5x0.5cm, away from least margin by 1 cm, (superior margin)

2- Fibrofatty tissue piece measured 9x6 cm. entangling 17 nodules ranging in size from 1 cm to 1.5 cm.

• Frozen section: Free margins

Microscopic examination:

- No remnants of tumor tissue in a previously diagnosed invasive carcinoma
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Negative (0/17), with one node showed aggregates of histiocytic reaction.
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Complete Pathological response.

IPT:

CK (Done on suspicious node): Negative.

Diagnosis:

Left breast cancer, left BCS & SLN (post neoadjuvant);

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Patient Name	: كريمه عبد الرازق عبد النعيم	Request No.	: 13009647
Patient No.	: 28009010111482	Request Date	: 14/03/2023
Path No.	: 793/2023	Verification Date	: 06/04/2023
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

No remnants of tumor tissue

Free resection margins.

No Perineural invasion.

Lymph nodes: Negative (0/17), with one node showed aggregates of histiocytic reaction.

Complete pathological response

Stage: ypT0 ypN1

Signature

Prof.Dr.Gamal Abdelatty

Dr.Israa Magdy

Dr.Hoba Hazaar.

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 05/06/2023 11:07:59

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



Patient Name: Karima Abd Al Razek Abd Al Naeem Mahran	Date : 18/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left breast upper and lower inner quadrants spiculated lesions largest measures 2.5 x 3 cm with pathological enlarged left axillary lymph nodes largest measures 2 x 3 cm.
- Enlarged left internal mammary lymph nodes largest measures 0.9 cm in diameter.
- Prominent left supra clavicular lymph nodes.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Tiny gall bladder mural calcification.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.



Patient Name: Karima Abd Al Razek Abd Al Naeem Mahran	Date : 18/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID:	

- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Left iliac bone radiolucent lesion with striated appearance likely hemangioma.
- Right iliac bone and right ala of sacrum sclerotic foci likely bone islands.

Opinion:

- Left breast neoplastic lesions with pathological left axillary and left internal mammary lymphadenopathy.
- Right iliac bone and right ala of sacrum sclerotic foci likely bone islands.
- No metastatic hepatic or pulmonary deposits.

Dr. Aya Deabes, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.



Patient Name: Karima Abd Al Razek Abd Al Naeem Mahran	Date : 21/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 3166/2022	Pat. ID: 15717

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

21/12/2023 2:35 PM

7/06/2023, 14:29

code:42 -- Name_A MDT form Harmal -- Name_E MDT form Harmal



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



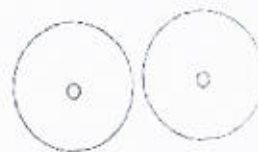
MDT form

3- Medical number:
Female

83088026
Old Med :

3166/2022

Patient Age : 43 Y



REASON OF MDT POST OPERATIVE

Date of MDT 2023-06-17

Family history

Phone

01100509425
01017516166

BMI

NRS Score

GROUP

marital status

Menopausal status

Co morbidity

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
bone scan :free

BX:
IDC

ER:
0/8

PR:
0/8

Her 2 Neu :
3

SISH :

Ki67 :
25

T
2

N
1

M
0

Sonomammography

multi focal lt malignant masses with ipsilateral lymphadenopathy
2/2023:POST NACT status for lt breast malignancy showing evidence of partial therapeutic response
(BIRADS 6)

PATIENT HISTORY

PT FINISHED 18 wks TC+6HP with good clinical response
lt BCS+SLNB: NEW PATHOLOGY

free margins

no remnants of tumor tissue, no perineural invasion

0/17

COMPLETE pathologic response YPT0,YPNO

MDT OUTCOME & PLAN

for: PORT, continue TDM1 for 1 y

repeat ER, PR on surgical specimen and if HR+ reMDT

On revision of IHC on surgical specimen, the pathology report was vigorously different showing PCR which
was yp T0N1/17 ; so to complete 1 year of HP& PORT

SIGNATURE		
MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY
SURGERY		PATHOLOGY
Psychiatric		Nutrition